

儿童过敏性鼻炎诊疗指南

一、疾病定义与病因

1.1 疾病定义

儿童过敏性鼻炎（AR）是特应性个体接触过敏原后，由 IgE 介导的鼻黏膜非感染性慢性炎症性疾病。典型四大症状为：阵发性喷嚏、清水样涕、鼻塞、鼻痒，可伴眼痒、流泪等眼部症状。我国儿童 AR 患病率约为 15%-20%，且呈逐年上升趋势。

1.2 主要病因

过敏性鼻炎是遗传因素与环境因素共同作用的结果。

分类

常见过敏原

吸入性过敏原（最主要）

尘螨、花粉（春季树木花粉、秋季蒿草花粉）、动物皮屑、蟑螂、真菌孢

食入性过敏原

牛奶、鸡蛋、花生、海鲜、坚果（婴幼儿更常见）

诱发加重因素：冷空气刺激、空气污染（PM2.5、二手烟）、上呼吸道感染。

二、典型症状与体征

2.1 主要症状

- 喷嚏：阵发性发作，常以晨起或接触过敏原后明显，每次数个至十余个。
- 清水样涕：大量清水样鼻涕，严重时可不自主从鼻孔滴下。
- 鼻塞：双侧或单侧鼻塞，严重者夜间张口呼吸，打鼾。
- 鼻痒：患儿常表现为揉鼻子、抠鼻子，形成“过敏性鼻炎敬礼”动作——手掌向上推鼻尖使鼻梁出现横行皱纹（过敏性鼻炎皱褶）。
- 眼部症状：眼痒、流泪、结膜充血，即“过敏性结膜炎”表现。

2.2 伴随体征

- “过敏性黑眼圈”：因鼻腔充血导致下眼睑静脉回流障碍，出现暗影。
- 咽部体征：鼻后滴漏刺激咽部，可见咽后壁淋巴滤泡增生（“鹅卵石样”外观）。

三、诊断标准与检查方法

3.1 诊断标准

典型四大症状（打喷嚏、流清涕、鼻塞、鼻痒）中出现 2 项或以上，且症状持续或累计超过 1 小时/天，即可临床诊断。确诊需结合过敏原检测。

3.2 辅助检查

检查项目	目的与临床意义
皮肤点刺试验（SPT）	前臂滴加过敏原液后轻轻刺入皮肤浅层，15-20 分钟后观察风团大小。阳性提示过敏原过敏。
血清特异性 IgE 检测	抽血检测针对尘螨、花粉等的特异性 IgE 抗体，不受皮肤状态和服药影响。
鼻分泌物涂片	嗜酸性粒细胞计数增高提示过敏。
鼻内镜检查	可见鼻黏膜苍白水肿、下鼻甲肿大、鼻腔水样分泌物。

四、治疗方案（包括常用药物）

过敏性鼻炎的治疗遵循“四位一体”原则：环境控制、药物治疗、免疫治疗、健康教育。

4.1 环境控制（避免接触过敏原）

- 防尘螨：床单被套 55℃以上热水烫洗，不用地毯、布艺沙发，使用防螨床品。
- 花粉防护：花粉季节戴口罩、护目镜，关闭门窗，使用空气净化器。

4.2 药物治疗（阶梯用药）

药物类别	常用药物（儿童）	作用与注意事项
鼻用糖皮质激素（一线首选）	糠酸莫米松鼻喷雾剂、丙酸氟替卡松鼻喷雾剂	全面控制鼻部四大症状，需连续使用 2-4 周，副作用极小，3 岁以上可用。
口服抗组胺药	西替利嗪滴剂、氯雷他定糖浆	快速缓解打喷嚏、流涕、鼻痒，对鼻塞效果有限。

药物类别	常用药物（儿童）	作用与注意事项
		二代（无嗜睡副作用）。
鼻用抗组胺药	氮草斯汀鼻喷雾剂	起效快，可“按需使用”，缓解急性发作。
白三烯受体拮抗剂	孟鲁司特钠（颗粒/咀嚼片）	尤其适用于合并哮喘、腺样体肥大的患儿，效果较好。

4.3 免疫治疗（脱敏治疗，唯一对因治疗）

- 适应症：明确单一过敏原（如尘螨）的中重度 AR 患儿，年龄 ≥5 岁。
- 方式：舌下含服（每日一次）或皮下注射，疗程 3 年。
- 效果：可改变疾病自然进程，降低新发过敏原和哮喘风险。

4.4 鼻腔冲洗

使用生理盐水或高渗海水冲洗鼻腔，可清除分泌物和过敏原，缓解鼻塞，适用于各年龄段。

五、家庭护理与预防建议

1. 规律用药：鼻用激素需坚持足疗程，不可症状一好转就停药，否则易反复。
2. 环境维护：明确过敏原后针对性规避，如花粉季关闭卧室窗户、使用空气净化器。
3. 锻炼身体：适当户外运动增强抵抗力，冷水洗脸可能有助于增强鼻黏膜耐受力。
4. 监测合并症：AR 患儿约 40% 合并哮喘，若出现反复咳嗽、喘息，需同时排查哮喘。
5. 定期随访：每 3-6 个月复诊，评估症状控制情况及调整用药方案。